

ENQUADRAR (DSM-5)

TNC leve x maior

O que separa = independência nas AVD (leve preserva; maior perde)

Fluxo

Síndrome → excluir reversível → neuroimagem → etiologia

Regra

Todo TNC: labs + 1 neuroimagem ao menos uma vez

REVERSÍVEIS · HPN

Tratáveis

B12 · tireoide · depressão · fármacos · HSD · metabólico

HPN (tríade Hakim)

Marcha magnética + incontinência + cognição disexecutiva

HPN imagem/conduta

RM: ventrículos ↑ / DESH, Evans > 0,3 · tap test → DVP

SUBTIPOS

Alzheimer

Memória episódica; não melhora c/ pistas; atrofia hipocampal

Vascular

Executivo, degraus, fatores vasculares; lacunas/leucoaraiose

Frontotemporal

Conduta/linguagem; <65a; memória poupada no início

Corpos de Lewy

Flutuação + alucinação visual + parkinsonismo; ↑ sensib. neuroléptico; REM

INVESTIGAR & MISTA

Laboratório

TSH, B12, Na/Ca, função renal/hepática, sífilis/HIV

Neuroimagem

TC/RM: exclui tratável (HPN/HSD) + apoia subtipo

Biomarcadores (ATN)

LCR Aβ/tau, PET — casos selecionados, não rastreio

No idoso

Demência MISTA é a regra; trate cada eixo tratável

RÉGUA DO DIAGNÓSTICO

Diante do declínio, três perguntas em ordem: 1) É TNC? (leve x maior = funcionalidade) 2) É REVERSÍVEL? (não perca a HPN!) 3) QUAL SUBTIPO? (pela 1ª queixa). Excluir o tratável vem ANTES de rotular degenerativa.

ALERTAS

- **HPN** = cognição + marcha + incontinência → investigar (reversível).
- **Corpos de Lewy**: extrema cautela com neurolépticos típicos.
- **Não** chame todo declínio de Alzheimer.